

恶心与呕吐相关医学知识体系

一、 基础定义、分类与病理生理学机制

恶心是一种迫切想要呕吐的主观不适感，常伴有胃部空虚感、唾液分泌增多、出汗、面色苍白、心动过速等自主神经功能紊乱的症状。呕吐则是通过胃、膈肌和腹肌的协同强力收缩，使胃内容物经口腔被迫排出的反射性动作。干呕是指有呕吐动作但无胃内容物排出，通常发生在呕吐之前。

从病理生理学角度，呕吐是由大脑的“呕吐中枢”协调的复杂反射动作。该过程涉及多个关键环节：

呕吐中枢：位于延髓网状结构，是协调呕吐反射的“总指挥部”。它接收来自以下各区域的信号并发出呕吐指令。

化学感受器触发区：位于延髓第四脑室底部的最后区。该区域缺乏血-脑屏障，可直接监测血液和脑脊液中的有害物质（如药物、毒素、代谢废物），并将信号传递至呕吐中枢。多巴胺（D2）、5-羟色胺（5-HT3）、神经激肽-1（NK-1）等受体在此密集分布。

传入神经通路：

内脏传入通路：消化道（特别是胃、十二指肠）、心脏、肝、胆、胰等器官的刺激（如扩张、炎症、缺血），通过迷走神经和内脏神经将信号传至呕吐中枢。

前庭系统：内耳前庭器的刺激（如晕动病、迷路炎）通过前庭神经核与呕吐中枢联系，主要与组胺 H1 和毒蕈碱 M1 受体相关。

大脑皮层与边缘系统：精神心理因素（如恐惧、焦虑、令人不快的视觉或嗅觉刺激）以及颅内压增高（如脑肿瘤、出血）可直接或间接影响呕吐中枢。

其他：咽喉部的刺激（如吸痰、插管）也可触发呕吐反射。

呕吐的分类可根据其病理生理主导机制分为：反射性呕吐（由内脏刺激引起）、中枢性呕吐（由化学感受器触发区或颅内病变直接引起）和前庭障碍性呕吐。

二、 临床表现与病因学鉴别

恶心呕吐的临床表现和伴随症状对病因鉴别至关重要。病因遍布全身各系统，以下按系统分类：

消化系统疾病：

感染与炎症：急性胃肠炎（常伴腹泻、腹痛）、急性胰腺炎（剧烈上腹痛、向背部放射）、急性胆囊炎（右上腹痛、墨菲征阳性）、病毒性肝炎（厌油、黄疸）。

梗阻性疾病：幽门梗阻（呕吐宿食、振水音）、肠梗阻（腹痛、腹胀、停止排气排便）。

其他：功能性消化不良、慢性胃炎、食物中毒。

中枢神经系统疾病：

颅内压增高：脑肿瘤、脑出血、脑膜炎。特征为喷射性呕吐，且呕吐前常无恶心或很轻微，多伴有剧烈头痛、视乳头水肿。

前庭功能障碍：晕动病、梅尼埃病（伴眩晕、耳鸣、听力下降）、迷路炎。

内分泌与代谢性疾病：

糖尿病酮症酸中毒：伴深大呼吸、烂苹果味呼气、意识改变。

尿毒症：伴氨味呼气、贫血、浮肿。

甲状腺危象、肾上腺皮质功能危象。

心血管疾病：

急性心肌梗死：尤其下壁心梗，可表现为突发上腹痛、恶心呕吐，而非典型胸痛。

急性心力衰竭。

药物与治疗相关因素：

化疗药物：是导致严重呕吐的最常见药物原因。

麻醉镇痛药：如吗啡、可待因。

抗生素：如红霉素、磺胺类。

放射治疗：尤其照射腹部时。

术后恶心呕吐：是全身麻醉后常见并发症。

精神心理因素：

神经性厌食、神经性贪食、焦虑症、躯体形式障碍等。

其他：

妊娠剧吐：多见于妊娠早期，与激素水平变化有关。

急性心肌梗死（尤其下壁心梗）等。

三、 诊断与鉴别诊断流程

对恶心呕吐患者的评估需系统化，以区分良性自限性疾病与危及生命的状况。

详尽病史采集：

特征：呕吐与进食的关系（餐后即刻或数小时后）、呕吐物的性质（含胆汁提示梗阻在十二指肠乳头以下；含宿食提示胃潴留；咖啡渣样提示上消化道出血）。

时间与诱因：急性起病还是慢性反复发作；与体位、用药、精神压力的关系。

伴随症状：这是鉴别的核心。必须询问有无腹痛、腹泻、发热、头痛、眩晕、胸痛、黄疸等。

全面体格检查：

一般情况：有无脱水征（皮肤干燥、眼窝凹陷）、营养状况。

腹部检查：视诊（胃肠型、蠕动波）、听诊（肠鸣音活跃或消失）、触诊（压痛、反跳痛、包块）、叩诊（鼓音、移动性浊音）。

神经系统检查：意识状态、瞳孔、脑膜刺激征、病理征、眼震。

其他：有无黄疸、淋巴结肿大。

针对性辅助检查：

基础检查：血常规（感染、贫血）、电解质与肾功能（了解水电解质紊乱情况）、血糖、淀粉酶/脂肪酶（怀疑胰腺炎）、肝功能。

影像学检查：

腹部 X 线平片：用于初步排查肠梗阻。

腹部超声：检查肝、胆、胰、肾等实质脏器。

腹部 CT：对不明原因的腹痛、呕吐，CT 是更精确的检查，可发现梗阻、炎症、缺血等病变。

头颅 CT/MRI：怀疑中枢神经系统病变时必查。

内镜检查：怀疑上消化道病变（如溃疡、胃癌）时可行胃镜检查。

心电图：对于高危患者或伴有胸痛、胸闷者，应常规检查以排除心源性因素。

四、 治疗原则与管理策略

治疗原则包括纠正病因、控制症状、维持内环境稳定。

病因治疗：这是最根本的治疗。如抗感染治疗急性胃肠炎，解除肠梗阻，降低颅内压，停用致吐药物，治疗心肌梗死等。

对症止吐治疗：

根据呕吐的主导机制选择止吐药，联合用药常优于单一用药：

5-HT₃ 受体拮抗剂（如昂丹司琼、格拉司琼）：强效止吐药，是化疗所致呕吐和术后恶心呕吐的预防和治疗基石，对其他原因所致呕吐也有效。

多巴胺（D₂）受体拮抗剂（如甲氧氯普胺/胃复安、多潘立酮）：对消化系统功能紊乱、药物、尿毒症等引起的呕吐有效。甲氧氯普胺还有促进胃动力作用。

抗组胺（H₁）药和抗胆碱能药（如苯海拉明、东莨菪碱）：主要用于前庭性呕吐，如晕动病、梅尼埃病。

神经激肽-1（NK-1）受体拮抗剂（如阿瑞匹坦）：与 **5-HT₃ 受体拮抗剂**和地塞米松联用，用于预防高致吐性化疗引起的急性和延迟性呕吐。

糖皮质激素（如地塞米松）：本身有止吐作用，常与上述药物联用于化疗止吐方案。

其他：对于精神心理因素或预期性呕吐，苯二氮草类药物（如劳拉西泮）可能有效。

支持治疗与并发症管理：

补液与纠正电解质紊乱：急性呕吐易导致脱水、低钾、低氯、代谢性碱中毒。根据脱水程度口服或静脉补液是基础治疗。

营养支持：呕吐剧烈时应暂禁食，症状缓解后从清淡流质开始逐步恢复饮食。长期慢性呕吐需注意营养支持。

保护胃黏膜：可酌情使用抑酸剂（如质子泵抑制剂）或胃黏膜保护剂。

五、 特殊考虑与患者教育

儿童：儿童呕吐常见于感染、喂养不当、肠套叠等。需特别注意评估脱水程度。

老年人：老年人呕吐阈值可能升高，呕吐症状不典型，但并发症（如吸入性肺炎、电解质紊乱）风险更高，且需警惕恶性肿瘤、心肌梗死等严重病因。

妊娠期：妊娠剧吐需排除其他疾病后诊断。治疗以支持为主，维生素 **B₆**、多西拉敏-吡哆醇复合制剂是一线选择，严重者需住院补液营养支持。

患者教育：

告知患者少量多餐，避免油腻、辛辣、过甜食物。

呕吐期间补充水分宜采用少量多次饮用口服补液盐或清液的方式。

若出现以下警报征象需立即就医：呕吐物带血或呈咖啡渣样、剧烈腹痛、高热、严重头痛、意识模糊、呕吐持续超过 24 小时无法进食。

总结而言，恶心呕吐是涉及多系统的常见症状，其临床管理需要细致的病史询问和体格检查以明确病因，并采取针对性的病因治疗和阶梯式的止吐对症支持策略，同时密切关注和预防并发症。